

3.3.15. Galsulfase (如 Naglazyme) : (106/10/1、107/12/1)

1. 病患須符合以下診斷條件：須證明患者之週邊血液白血球或經培養之皮膚纖維芽細胞 ARSB 活性缺乏，或是患者 ARSB 基因經分子生物學檢驗確認有兩個分別來自父母雙方，已知或必然會引起黏多醣症第六型之突變。
2. 限兒科專科經醫學遺傳學次專科訓練取得證書之醫師使用。
3. 排除使用於：
 - (1) 患者若未給予治療，並不會導致健康情況之惡化時。
 - (2) 重型病患：完全臥床且無行動能力，或是無法自行呼吸且完全仰賴呼吸器維生者。
 - (3) 早期診斷帶有已知嚴重突變點的病患，但無明顯臨床症狀者。
4. 標準劑量為每週經靜脈注射給予 galsulfase 1 mg/Kg。
5. 黏多醣症第六型對於器官之傷害多屬不可逆性，治療前應與患者及家屬充分溝通告知下列事項，並請其簽名確認已被告知，留存病歷備查：
 - (1) 確定其了解治療的預期效果。
 - (2) 患者有義務接受定期追蹤評估。
6. 應定期追蹤評估治療效果及下列事項：
 - (1) 至少每半年追蹤一次：
 - I. 身高體重；
 - II. 尿液黏多醣量；
 - (2) 至少每一年追蹤一次：
 - I. 腹部超音波、肝臟大小、脾臟大小；
 - II. 心電圖；
 - III. 心臟超音波；
 - IV. 六分鐘步行測驗 (6-minute walk test) 或於5歲以下幼童以 DDST (Denver Developmental Screening Test) 粗動作及精細動作 (Gross Motor and Fine Motor) 檢測；(107/12/1)；
 - V. 肺功能；
7. 需經事前審查核准後使用，每次申請之療程以1年為限。重新申請時，若有下列任一情況，則不再給予 galsulfase 治療：(107/12/1)
 - (1) 尿中葡萄糖胺聚醣與肌酸酐比值：於接受治療的第一年之後評估，較前一年有50%以上的增加；第二年之後評估，較之前一年有100%以上的增加。(107/12/1)
 - (2) 六分鐘步行測驗：較之前一年退步50%以上或連續2年有退步現象；5歲以下幼童以 DDST 粗動作及精細動作檢測，發展進程年齡與實際年齡商數低於60%，或比初次檢測時之發展進程年齡退步。(107/12/1)
 - (3) 呼吸功能檢查：在未供給任何氧氣治療下，血液中氧氣飽和度在2小時內無法持續維持1小時以上 $\geq 90\%$ 。(107/12/1)
8. 須立即停止 galsulfase 治療的情形：
 - (1) 有證據顯示病人開始呈現明顯的中樞神經系統退化之臨床表徵。
 - (2) 病人在接受治療時發生其它致命的疾病，這表示病人無法獲得 galsulfase 的療效。
 - (3) 病人發生嚴重不良反應。
 - (4) 病人無法配合最適療程所需的注射規定或無法配合療效的評估。